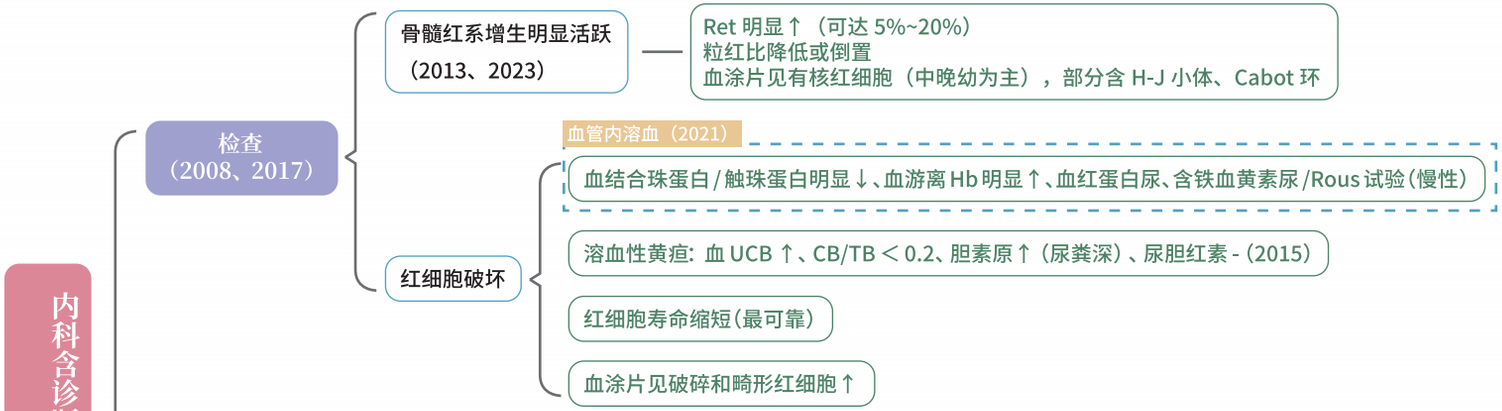


类型（若为遗传需关注家族史）	
遗传球	血涂片球形细胞↑、渗透脆性↑（0.62%NaCl 开始破裂）。切脾（≥ 6 岁以避免肺炎链球菌感染的 OPSI，2019）
G6PD 缺乏症	G6PD 活性测定（确诊）、高铁血红蛋白还原试验 MHbRT
珠蛋白生成障碍性贫血（2008）	血红蛋白电泳 HbEP、异丙醇“一只小猪游泳”、小细胞低色素（MCHC ＜ 32%）、靶形红细胞“地中海打靶”。HSCT 根治
自免溶（2017）	①温：Coombs（诊断）、可有球形细胞↑。糖皮质激素（首选）、利妥昔单抗、切脾。Evans 综合征即温抗体自免溶 +ITP ②冷：冷凝集素。保暖、利妥昔单抗
阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH（2024）	慢性起病，晨起酱油尿 流式细胞术 FLAER(-) 和 GPI 锚链膜蛋白 CD55/59 ↓（诊断）、酸溶血 Ham、蔗糖溶血、蛇毒因子溶血、Rous、NAP ↓ 可合并缺铁贫、与再障可相互转化（可全血细胞↓）、可肝静脉血栓形成（死因） 治疗：依库珠单抗抑制补体、HSCT 根治 “在优衣库打酱油的智障赶紧睡觉、老铁服啦我我我就睡觉”